

TRAUMATISMO OCULAR

Norma H. Garrahan

Dra. Norma Graifman *

Dra. Rosa Bologna **

CONSIDERACIONES GENERALES

Interrogatorio

Examen:

- Agudeza visual: Debe investigarse cada ojo por separado. Si se dispone de un cartel de prueba usarlo, si no está disponible o el niño no colabora por corta edad o por no estar en condiciones, el pediatra debe controlar si el ojo sigue los movimientos de la mano y/o si fija, para esto colocar delante del mismo un objeto coloreado o una linterna y moverlo (evitar llamar la atención con la palabra).
- Colocar colirio anestésico para facilitar el examen, **NO PRESCRIBIRLO** después.
- Investigación externa de los párpados. Buscar heridas, tener en cuenta que en el tercio interno de los mismos, si hay secciones, estas involucran generalmente las vías lagrimales.

En caso de heridas de párpados que comprometen todo el espesor, debe descartarse una herida perforante del globo ocular. Si el niño presenta resistencia a la apertura de los párpados, evitar forzarla (existe peligro de estallido del globo ocular en caso de que éste estuviera afectado).

El exámen y/o exploración lo realizará el especialista.

- En casos de quemaduras químicas forzar la apertura con separador de párpados.
- En contusiones severas solicitar estudios radiográficos, para pesquisar fracturas óseas.

TENER EN CUENTA QUE EN UN MISMO PACIENTE SE PUEDEN PRESENTAR UNA O MÁS DE LAS SITUACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

LESIONES PALPEBRALES

- Limpieza: iodopovidona (no lesiona el ojo), luego de la limpieza sacar el excedente.
- Colocar colirio anestésico, **no prescribirlo** después.
- Sutura de los párpados respetando los planos. En caso de compromiso de los canalículos lagrimales (tercio interno), se debe colocar un tutor en el mismo y luego suturar, sino derivar al especialista (cirujano plástico u oftalmólogo). Se puede esperar 24/48 horas, pero nunca se debe suturar sin el tutor.
- Profilaxis antibiótica: en aquellas heridas profundas y con bordes anfractuosos, se aconseja: Amoxicilina - ác. clavulánico ó Amoxicilina - sulbactam, 40 mg/kg/día de amoxicilina, c/8 hs, V.O., durante 3 a 5 días.
- Vacunas: Antitetánica y/o antirrábica (Ver Criterios de Atención “Heridas por mordeduras”).

LESIONES ORBITARIAS (HEMORRAGIAS, ENFISEMA, CUERPOS EXTRAÑOS, FRACTURAS)

- Interrogatorio e inspección de párpados y ojo externo.
- Estudio radiográfico.
- Consultar con oftalmólogo y/o cirujano plástico.
- Colocar colirio anestésico, **no prescribirlo** después.

* Servicio de Oftalmología

** Servicio de Infectología

- Profilaxis antibiótica: en casos de fractura de órbita o cuerpo extraño, se aconseja:
Cefuroxina 150 mg/kg/día, E.V., c/8 hs, durante 3 a 5 días.
ó Ceftriaxona 70 mg/kg/día, I.M., una dosis diaria, durante 3 a 5 días.
- Vacunas: Antitetánica y/o antirrábica.

EROSIONES CORNEALES

- Diagnóstico: instalar una gota de fluoresceína de sodio al 0,25 %. La superficie de la córnea erosionada tiñe de color verde.
- Colocar colirio anestésico, **no prescribirlo** después.
- Colirios con antibióticos (1 gota c/3 hs).
- Colirios cicloplégicos. (atropina 1% c/12 hs., ciclopentolato 1%) c/8 hs.
- No ocluir.
- Derivar al especialista.

LESIONES CONJUNTIVALES (HERIDAS O HEMORRAGIAS)

- Colocar colirio anestésico, **no prescribirlo** después.
- Recordar que puede haber una lesión del globo. Inspección sin forzar.
- Colirio con antibióticos.
- Derivar al especialista.

HERIDAS PENETRANTES DEL GLOBO OCULAR, CUERPOS EXTRAÑOS INTRAOCULARES

- Colocar colirio anestésico, **no prescribirlo** después.
- Colirios con antibióticos.
- Colirios cicloplégicos (atropina 1%, 2 gotas).
- Reposo.
- Derivar al especialista en forma urgente.
- Vendaje oclusivo no compresivo.
- Profilaxis antibiótica: (sistémicos)
Ceftazidime 100 mg/kg/día, E.V., c/8 hs.
+
Rifampicina 20 mg/kg/día, V.O., c/12 hs, durante 5 días.
- Vacunas: antitetánica y/o antirrábica.

TRAUMAS CONTUSOS DONDE SE SOSPECHA O SE VE HEMORRAGIA INTRAOCULAR

- Colocar colirio anestésico, **no prescribirlo** después.
- Reposo en posición semisentada (con esto se busca que la sangre forme nivel líquido).
- La oclusión no es imprescindible pero a veces se indica en forma bilateral a fin de inmovilizar los ojos.
- Derivar al especialista.

QUEMADURAS QUIMICAS

- Lavado con solución salina o agua durante al menos 30 minutos, puede ser necesario prolongarlo por horas.
- Controlar con papel indicador de pH, y continuar el lavado hasta que el pH se encuentre entre 7,3 y 7,7.
- Pueden requerirse analgésicos, colirio anestésico y separador de párpados. Abrir en forma forzada los párpados para facilitar la limpieza.

- Mientras se procede al lavado, con hisopos de algodón, retirar en forma forzada de la conjuntiva y de los fondos de sacos conjuntivales todos los vestigios de sustancias extrañas que se encuentren.
- Colirios locales con atropina al 1% c/ 8 hs.
- Colirio con antibióticos.
- Vendaje oclusivo no compresivo.
- Derivar al especialista.

BIBLIOGRAFIA

- Zambrano, A., Grigera, D., et. al. Traumatismos del globo ocular. Arch. Oftalmol. 1986; 61: 263-310.
- Duke-Elder. System of ophthalmology. Vol 16, Part. 1p. 64-310. London: Henry Kimpton, 1972.
- Shingleton, B., Hersch, P., Kenyon, K. Traumatismos oculares. Madrid. Mosby Year Book, 1992.
- Eagling, E. M., Ropper-Hall. Eye injuries: an illustrated guide. Gower. 1986.
- Spoor, T., Nesi, F. Management of ocular, orbital and adnexal trauma. New York. Raven Press. 1988.

Se agradece la revisión del tema “Traumatismo ocular” al Dr. Julio Manzitti.